

20대 남성 다한증 원인부터 치료 순서까지

손·발·겨드랑이 땀이 생활을 방해할 때, 원인 질환이 없는 '원발성'인지 확인하고 단계적으로 치료합니다

20대 초반이면 먼저 '원발성 국소 다한증'을 봅니다

원발성 = 특별한 원인 질환 없이 특정 부위에만 땀이 많은 것 — 전신 질환보다 흔합니다



1

흔한 모습

사춘기~20대 초반에 시작해 손·발·겨드랑이에 땀이 많고, 양쪽이 비슷하며, 긴장하거나 더우면 심해집니다.

특정 부위 · 양쪽 · 자는 동안 줄어듦



2

먼저 확인할 경우

온몸에 땀이 나거나 밤에 흠뻑 젖는 경우, 체중 감소·열·두근거림이 함께 있으면 다른 원인이 있는지 **먼저** 살핍니다.

원인 질환 먼저 확인



3

현실적인 목표

땀을 아예 없애기보다 **생활의 불편을 덜기**가 목표입니다. 땀 불편 점수가 1~2점 내려가는지 봅니다.

점수로 효과 확인

Tip · 원발성 다한증은 가족 중에 비슷한 분이 있는 경우가 많습니다.

근거 · 미국가정의학회(AAFP) 2018 다한증 치료

진단은 '6개월 + 생활 방해 + 특정 부위'입니다

검사보다 문진과 부위 확인이 먼저입니다

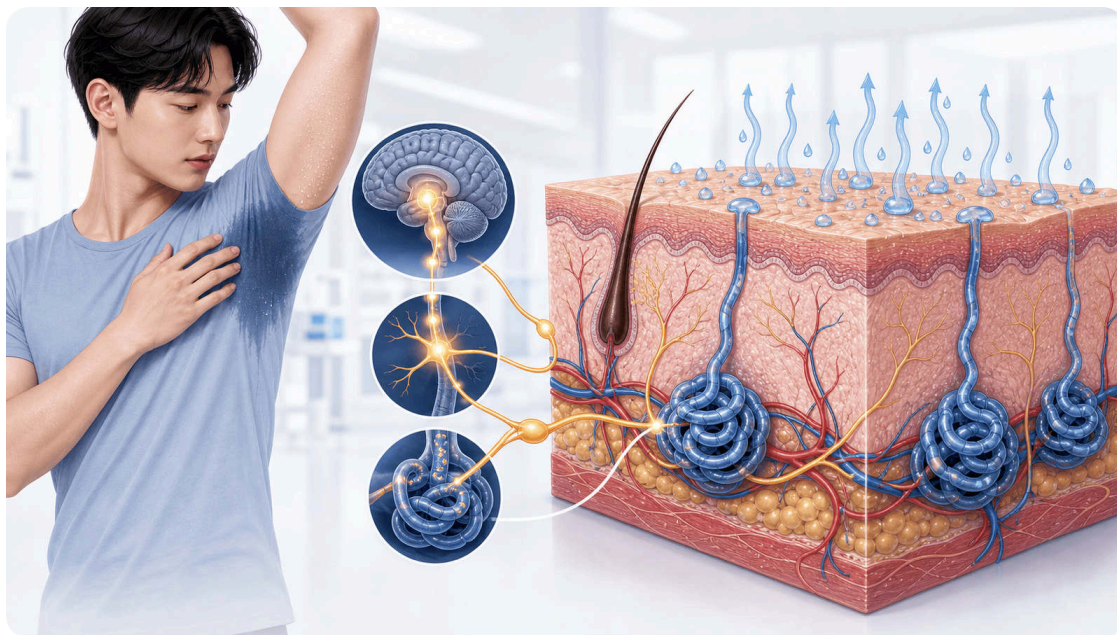


그림 · 신경 신호가 땀샘을 지나치게 자극해 특정 부위에 땀이 많아집니다(설명용 그림).

1 6개월 넘게 지속

뚜렷한 원인 없이 특정 부위 땀이 6개월 넘게 되풀이됩니다.

2 양쪽이 비슷하게 대칭

한쪽만 심하면 신경·피부의 다른 원인을 찾아야 합니다.

3 주 1회 넘게 생활을 방해 기능

악수·필기·운동·대인관계·옷 젖음 등 불편을 묻습니다.

4 25세 전 시작 · 자는 동안 줄어듦 경과

가족력도 봅니다. 자면서도 계속 젖으면 전신 원인을 찾습니다.

Tip · 진료 전에 언제·어디서·얼마나 불편했는지 적어 오시면 진단이 빨라집니다.

근거 · 원발성 국소 다한증 진단 기준 · 땀 불편 점수(HDSS)

부위마다 치료가 달라집니다

손·발·겨드랑이·얼굴을 나눠 기록하면 치료 선택과 의뢰 시점이 분명해집니다

손바닥

약수·필기·휴대폰 터치가 불편합니다. 병역 판정에서는 손바닥 땀 기록이 특히 중요합니다.

발바닥

양말이 젖고 냄새·긁무름이 생깁니다. 손과 함께 이온영동 치료를 고려합니다.

겨드랑이

옷 젖음·냄새가 걱정됩니다. 바르는 약·주사 등 고를 수 있는 치료가 많습니다.

얼굴·두피

사회적 긴장과 잘 연결됩니다. 약 부작용이나 원인 질환을 더 꼼꼼히 봅니다.

심해지는 상황

더위·운동·발표·카페인·매운 음식·스트레스와 어떻게 연결되는지 적어 둡니다.

생활에 미치는 영향

피하게 되는 일, 자신감 저하, 불안·우울이 함께 있는지도 봅니다.

Tip · 부위별로 1~4점을 따로 적어 두면 어떤 치료가 어디에 들었는지 알 수 있습니다.

근거 · 국제다한증학회 · 진료 문진 항목

땀 불편 점수(HDSS)로 심한 정도와 효과를 숫자로 봅니다

'불편하다'를 1~4점으로 적으면 다음 단계가 분명해집니다

점수	느낌	일상생활
1점	거의 불편하지 않음	지장 없음
2점	참을 만함	가끔 방해 받음
3점	참기 어려움	자주 방해 받음 — 치료를 강화합니다
4점	견디기 어려움	늘 방해 받음 — 전문 치료 의뢰를 고려합니다

1점↓ 효과 있음
땀이 약 50% 줄어든 것으로 봅니다

2점↓ 효과 큼
땀이 약 80% 줄어든 수준입니다

3개월 기록
병역 판정·시술 의뢰에는 진료 기록과 경과가 중요합니다

Tip · 치료 전 점수를 적어 두어야 나중에 얼마나 좋아졌는지 비교할 수 있습니다.

근거 · 땀 불편 점수(HDSS) · 병역판정검사 규칙 다한증 항목

겨드랑이는 바르는 약부터 제대로 써 봅니다

효과가 없던 분도 바르는 시간·피부 상태가 맞지 않아 실패한 경우가 많습니다

염화알루미늄 10~20%

마른 피부에 자기 전에 바르고 6~8시간 뒤 씻어 냅니다. 면도 직후·상처·젖은 피부에는 자극이 심해 피합니다.

처방 바르는 약(국소 항콜린제)

겨드랑이용 소프피로니움 5% 겔 등이 있습니다. 바른 뒤 손을 씻고, 눈·입에 닿지 않게 합니다. 시야 흐림·입마름·소변 불편이 생기면 알립니다.

4주 뒤 다시 점수 매기기

한 달을 써도 점수가 전혀 내려가지 않으면 다음 단계로 갑니다. 따가움은 실패가 아니라 횡수·보습으로 조절합니다.



그림 · 샤워 뒤 겨드랑이를 완전히 말리고 자기 전에 바릅니다(설명용 그림).

Tip · 따가우면 이틀에 한 번으로 줄이거나 보습제를 함께 쓰면 계속 쓸 수 있습니다.

근거 · 염화알루미늄 10~20% · 국소 항콜린제 연구

손·발은 이온영동이 현실적인 다음 단계입니다

물에 손발을 담그고 약한 전류를 흘리는 치료 — 수술 없이 되풀이해 조절합니다

1 처음 2~4주 집중

주 2~4회, 한 번에 20~30분씩 합니다. 효과가 나면 간격을 늘립니다.

2 유지 치료 주 1회~격주

다시 땀이 나는 간격에 맞춰 조절합니다.

3 먼저 상담할 분 금기 확인

심장 박동기·부정맥·몸속 금속·임신 가능성이 있으면 먼저 알립니다.

4 잘 안 들으면 다음 단계

보툴리눔 독소 주사 — 손바닥은 통증과 일시적 손 힘 약화를 설명드리고 정합니다.



그림 · 물을 담은 쟁반에 손바닥을 대고 약한 전류를 흘립니다(설명용 그림).

Tip · 시술보다 먼저 꾸준한 반복과 유지 계획을 세우면 수술 뒤 생기는 다른 부위 땀 걱정 없이 치료할 수 있습니다.

근거 · 국제다한증학회 치료 흐름도

먹는 약은 '필요한 상황에 골라서' 씁니다

활동량이 많은 20대는 운동·더위·운전·소변 문제를 함께 따집니다

도움이 되는 경우

짧고 예측되는 상황에 씁니다.

- 시험·면접·발표 같은 날 잠깐 쓰기
- 여러 부위가 함께 불편하고 바르는 약·이온영동으로 부족할 때
- 가장 적은 양부터, 입마름·변비·졸림·시야 흐림을 보며 조절
- 효과가 있어도 부작용 때문에 오래 쓰기 어려울 수 있음

VS

특히 조심할 때

땀을 막아 몸의 열이 빠지지 않을 수 있습니다.

- 더운 곳·격한 운동 — 열 관련 질환 위험
- 시야가 흐려 운전이 불편하면 시간·양을 바로 조정
- 소변이 잘 안 나옴·변비·심한 입마름은 멈추고 상담
- 비슷한 계열의 약을 이미 먹고 있다면 함께 따짐

Tip · 옥시부티난·글리코피롤레이트 같은 먹는 약은 '항콜린제'라고 부르는 한 계열입니다.

근거 · 먹는 항콜린제 안전성 · 미국가정의학회 2018

시술은 부위와 효과 기간을 나눠 고릅니다

바르는 약·이온영동 뒤에도 3~4점이 계속되면 피부과·흉부외과 의뢰를 검토합니다



그림 · 땀 나는 자리를 표시하고 격자로 나눠 주사합니다(설명용 그림).

보툴리눔 독소 주사

겨드랑이에서 근거가 가장 강하고 몇 달 효과를 기대합니다. 손바닥은 통증과 일시적 손 힘 약화를 설명드립니다.

땀 나는 자리 표시

요오드와 전분을 바르는 검사로 땀 나는 면적을 확인하고 격자로 나눠 주사합니다.

미라드라이 — 겨드랑이 전용

건강보험이 안 되고 붓기·감각 이상이 생길 수 있어 오래가는 효과와 비용을 함께 비교합니다.

Tip · 시술은 완치보다 조절입니다 — 다시 맞아야 할 수 있고, 효과 기간·보험·비용을 미리 확인합니다.

근거 · 보툴리눔 독소 겨드랑이 다한증 연구 · 미라드라이 임상 자료

온몸 땀은 원인부터, 교감신경 수술은 마지막 선택입니다

원인 질환이 숨어 있거나 수술 뒤 다른 부위에 땀이 늘면 되돌리기 어렵습니다

이럴 때	이렇게 합니다
온몸 · 밤에 흠뻑 · 새로 시작	성인이 된 뒤 갑자기 생겼거나, 밤에 흠뻑 젖거나, 한쪽만 심하면 원인 찾기 가 먼저입니다
함께 있는 증상	체중 감소·열·림프샘 붓기, 갑상샘 증상, 두통과 함께 혈압이 갑자기 오르면 그에 맞는 검사를 합니다
교감신경 절제술(ETS)	수술 뒤 다른 부위 땀(보상성 다한증)이 흔하고 심할 수 있어, 심한 손 다한증에서 마지막 수단 으로만 논의합니다
겨드랑이만 불편할 때	수술은 신중히 — 바르는 약·처방 바르는 약·보툴리눔 독소·미라드라이를 먼저 비교합니다

Tip · 밤에 흠뻑 젖는 땀·체중 감소·열·두근거림이 있으면 바로 진료받으세요.

근거 · 이차성 다한증 위험 신호 · 교감신경 절제술 보상성 다한증 연구

진료 뒤 4주 동안 해 볼 여덟 가지

기록이 쌓이면 치료 효과, 병역 서류, 전문의 의뢰 판단이 모두 쉬워집니다

01 손·발·거드랑이를 나눠 1~4점으로 적기

02 4주 땀 일지 — 시간·상황·젖은 옷·약수 불편

03 바르는 약은 마른 피부에, 자기 전에

04 먹는 약을 쓸 땐 더워·운동·시야·소변 살피기

05 손·발은 이온영동 일정과 금기 상담

06 병역 판정에 필요한 진료 기록은 미리

07 불안·발표 공포·자신감 저하도 말하기

08 밤 땀·체중 감소·열·두근거림은 바로 진료

Tip · 다한증은 참는 병이 아니라 기록하고 조절하는 병입니다.

근거 · 광교바른내과 다한증 초기 추적 계획

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

손·발·거드랑이 땀으로 불편한 분을 위한 설명자료입니다. 치료 단계와 시술 여부는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국가정의학회(AAFP) 2018 · 국제다한증학회 치료 흐름도 · 원발성 국소 다한증 진단 기준 · 땀 불편 점수 (HDSS) · 보툴리눔 독소·미라드라이 임상 자료 · 병역판정검사 규칙



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요